Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Veranópolis

Rua Doutor Idemundo Tedesco, 170 - Bairro: São Pelegrino - CEP: 95330000 - Fone: (54) 3022-9850 - Balcão Virtual: (54) 99620-8141 - Email: frveranopvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004745-33.2023.8.21.0078/RS

AUTOR: DECLEI CARMEN PADOVA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I - Relatório.

DECLEI CARMEN PADOVA, qualificada na inicial, propôs a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL- IPE-SAÚDE, igualmente identificado. Narrou a autora que está em tratamento de Neoplasia maligna da mama (CID: C50) e Neoplasia maligna secundária de outras localizações - CIC: C79. Disse que se submeteu a vários tratamentos cirúrgicos, quimioterápicos e complementares desde o ano de 2014, quando foi diagnosticada com Câncer de Mama, tratada com Setorectomia + Linfadenactomia seguida de quimioterapia adjuvante com esquema AC-T, radioterapia e hormonioterapia conanastrozol. Perfil Molecurardo tumor é receptor hormonal positivo, HER. Em 2019 durante a adjuvancia com Anastrazol, a autora evoluiu para recidiva hepática da doença. Foi tratada com Fulvestranto e Palbociclibe até 2022. Após evoluiu com progressão hepática, sendo tratada com Capecitabina até fevereiro 2023. A partir daí, iniciou Tamoxifeno que se estendeu até agosto deste ano quando houve nova progressão da doença, tratada com Doxorrubicina Lipossimal, porém em novembro houve nova progressão da doença hepática. Aduziu que necessita o fornecimento do medicamento *Sacituzumabe govitecana (Trodelvy).* Fundamentou seu pedido na cobertura do plano, na urgência do uso do medicamento, bem como na falta de condições financeiras para custear o tratamento. Postulou, inclusive em sede de tutela de urgência, a imediata concessão do fármaco. Requereu a gratuidade processual. Juntou documentos (Evento 1).

A inicial foi recebida e deferida a tutela de urgência [evento 3, DESPADEC1].

Citado, o réu apresentou contestação [evento 29, CONT1], alegando a falta de cobertura do plano para o medicamento postulado. Argumentou que a autora pretende um tratamento diferenciado que não será estendido aos demais segurados, ferindo o princípio da isonomia. Teceu considerações quanto à concessão de um tratamento que não integra as tabelas do plano, gerando a dilapidação de recursos do Fundo de Assistência à Saúde-FAS, expondo a perigo todos os beneficiários do IPE-Saúde. Afirmou a disponibilidade de outros medicamentos para o tratamento e a existência de alternativas terapêuticas a serem observadas no protocolo oncológico do instituto. Requereu a improcedência do pedido. Anexou documento.

Houve réplica [evento 35, RÉPLICA1].

Determinada a intimação das partes para manifestarem quanto ao interesse na produção de provas, ambas requereram o julgamento do feito no estado em que se encontra [evento 48, PET1 e evento 50, PET1].

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido [evento 53].

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Não há questões preliminares ou processuais pendentes de análise.

No mérito, tal como antevisto na decisão antecipatória de tutela, a responsabilidade do réu para o fornecimento do fármaco elencado na inicial em favor da parte autora é decorrência lógica da condição de segurada e das disposições da Lei Estadual n.º 15.145/2018, em especial, no artigo 4.º:

Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.

§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.

§ 2º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial.

§ 3º Para aprimoramento, qualificação, maior abrangência e efetividade de cobertura prestada na área da saúde, mediante prévio estudo técnico e atuarial, o Instituto poderá instituir Planos Especiais, para disponibilizar outros serviços ou procedimentos, cuja participação é opcional, mediante prévia solicitação e mensalidade específica, na forma

que dispuserem o regulamento e atos normativos expedidos pelo Instituto.

Ainda, a resolução n.º 21/1979 do IPE, no seu artigo 2º, diz:

Art.º 2º-O plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes coibirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento.

Assim, está fundada na lei a responsabilidade do IPE-SAÚDE em fornecer o atendimento médico e hospitalar, assim como os atos necessários ao diagnóstico e tratamento, razão pela qual não há como sustentar a justificativa da autarquia no sentido de que não há cobertura para o tratamento solicitado.

No caso dos autos, o pedido é o fornecimento do medicamento Sacituzumabe Govitecano (TRODELVY), necessário para o tratamento da doença que acomete a autora [Neoplasia maligna da mama (CID: C50) e Neoplasia maligna secundária de outras localizações (CIC: C79)].

O protocolo clínico, atualizado, prevê a cobertura do tratamento para a comorbidade, apenas exclui o medicamento em questão.

Frente a isso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem consolidado o entendimento de que a negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente demanda a apresentação de justificativa técnico-científica do IPE-Saúde, não bastando o indeferimento genérico, e que o critério utilizado pela Administração Pública em relação aos serviços do IPE-Saúde é a exclusão expressa, de modo que, via de regra, todos os procedimentos hospitalares e ambulatoriais são custeados, salvo aqueles expressamente excluídos.

Sobre a questão:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. *IPE*-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE *MEDICAMENTO* PARA TRATAMENTO *ONCOLÓGICO*: PEMBROLIZUMAB. DIAGNÓSTICO DE OUTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE PELE (CID 10 C44). SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Em se tratando de sentença que condenou o demandado *IPE*-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, autarquia estadual, ao custeio de tratamento em montante que supera o disposto no art. 496, §3º, é de ser conhecida da remessa necessária. 2. A pretensão da parte autora encontra guarida nas disposições do artigo 4º da Lei Complementar nº 15.145/18 e nas Recomendações em *Oncologia* do próprio *IPE*-SAÚDE – elaboradas pelo Comitê Científico de *Oncologia* e Hematologia da Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul - que dispõem que as orientações ali constantes "não têm pretensão de serem completas ou definitivas", restando destacado, também, que "a atuação *oncológica* é um fenômeno continuado que requer revisões frequentes". Assim, demonstrada a urgência, evidencia-se o acerto da determinação judicial compelindo ao fornecimento do *medicamento* ora postulado. 3. A relevância constitucional do direito à saúde, a previsão de cobertura para o tratamento *oncológico* postulado, conforme Lei Complementar nº 15.145/18 e Recomendações em *Oncologia* do próprio *IPE*-SAÚDE e as circunstâncias concretas demonstradas nos autos conduzem à confirmação da sentença proferida pelo juízo singular. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.(Remessa Necessária Cível, Nº 50048283920238210049, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 19-06-2024)

Ainda, o laudo médico [evento 1, LAUDO10] aponta as terapias já utilizadas pela autora:

TACCHINI
SISTEMA DE SAÚDE

Paciente:
DECLEI CARMEN PADOVA

CPF do Paciente:
433.180.290-68

Nascimento:
06/04/1949

Endereço:
EPTACIO PESSOA - 748, CASA - DUNEVA P- 981159522, SANTA LUCIA - 95330000, VERANOPOLIS - RS

Documento emitido via Mevo.
Para validar, acesse:
https://validar.iti.gov.br/

Código da solicitação: **MO3Z4VB**
Código de acesso: **6549**

Relatório

SOLICITO A MEDICAÇÃO SACITUZUMABE GOVITECANPARA A PACIENTE ACIMA PORTADORA DE CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA METASTATICO.
A PACIENTE TEVE DIAGNÓSTICO DO CANCER DE MAMA EM 10/01/2014, pT2pN2M0 EC IIIA, TRATADA COM SETORECTOMIA + LINFADENECTOMIA SEGUIDA DE QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE COM ESQUEMA AC-T, RADIOTERAPIA E HORMONIOTERAPIA COM ANASTROZOL.
PERFIL MOLECULAR DO TUMOR É RECEPTOR HORMONAL POSITIVO, HER -.
EM 2019 , DURANTE A ADJUVANCIA COM ANASTROZOL, PACIENTE EVOLUIU COM RECIDIVA HEPATICA DE DOENÇA.
INICIALMENTE FOI TRATADA COM FULVESTRANTO E PALBOCICLIBE (07/11/2019 A 04/2022).
APÓS EVOLUIU COM PROGRESSAO HEPATICA SENDO TRATADA COM CAPECITABINA NO PERIODO DE 05/2022 A 02/2023. POR NOVA PROGRESSAO FOI INICIADO TAMOXIFENO03/2023 A 08/2023. EM AGOSTO POR NOVA PROGRESSAO DE DOENÇA FOI TRATADA COM DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL (08/2023 A 11/2023). AGORA PACIENTE EVOLUINDO NOVAMENTE COM PROGRESSAO DE DOENÇA HEPATICA.
O MEDICAMENTO SACITUZUMABE GOVITECANO ESTA INDICADO PARA PACIENTES COM ESSE PERFIL DE DOENÇA.
O ESTUDO FASE 3 TROPICS-02 EVIDENCIOU REDUÇÃO DO RISCO DE MORTE EM 21% EM COMPARAÇÃO COM QUIMIOTERAPIA E AUMENTO DA SOBREVIDA.
NÃO DISPONHO DE OUTRAS ALTERNATIVAS NO MOMENTO.
ESSE MEDICAMENTO NÃO ESTÁ DISPONIVEL PELO SUS E ESTÁ APROVADO PELA ANVISA NESSA INDICAÇÃO.
SOLICITO O MEDICAMENTO COM URGENCIA, VISTO PACIENTE COM RISCO DE PROGRESSAO DA DOENÇA HEPATICA E MORTE.

Portanto, considerando os tratamentos já utilizados e o panorama de saúde da parte autora descrito nos laudos médicos, resta comprovada a necessidade de uso do medicamento, não comportando o processo qualquer outra discussão acerca do fornecimento do fármaco em favor da parte autora.

Isso posto, ratificando os termos da decisão antecipatória de tutela, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na presente ação condenatória proposta por DECLEI CARMEN PADOVA em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - IPE-SAÚDE para condenar o réu a fornecer à autora o medicamento *Sacituzumabe govitecana*, conforme prescrição médica indicada.

Condeno também o réu ao pagamento das despesas processuais (isento da taxa única) e honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, o qual arbitro em 10% do valor da causa, na do artigo 85, CPC, que deverá ser corrigido monetariamente pela Taxa SELIC, a contar do trânsito em julgado.

Publicada, registrada e intimadas as partes eletronicamente.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para querendo, apresentar contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, intimem-se as partes e baixe-se o processo.

Documento assinado eletronicamente por **VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA, Juíza de Direito**, em 16/9/2024, às 16:11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10067812527v7** e o código CRC **69595625**.